予想問題 第2回

英　　語

（ 80 分 ・ 100 点 ）

問　題

（問題 2〜6 ページ・解答用紙 7〜9 ページ）

大分大学 一般選抜 前期日程 対策

医学部（医学科・先進医療科学科）

はじめに読むこと

1. 解答時間は 80 分。時間の目安は，〔1〕35 分，〔2〕30 分，〔3〕12 分，見直し 3 分。
2. 大問は 3 題。100 点満点（〔1〕40 点・〔2〕36 点・〔3〕24 点）。大問・小問の配点は編集部の想定である。
3. 〔1〕は教育学部・経済学部・医学部の 3 つの版に共通の問題である（同じ回なら同じ英文・同じ設問。配点だけが違う）。
4. 答えは巻末の解答用紙（大問ごとに 1 枚・切り取り可）の決められた欄に書くこと。
5. 英文・日本文はすべて編集部が新しく作ったもので，人物・団体・地名・調査・数値はすべて架空である。

大分大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。
出題の傾向を研究し，編集部が一から書き下ろした演習用の冊子です。

1 長文読解（配点 40）

次の英文を読み，下の設問に答えなさい。

In Praise of Boredom

1 Ask a group of parents what they dread most during the long summer holiday, and many will give the same answer: the moment their child says, “I’m bored.” Some respond by （ ① ） every hour of the day with lessons, sports and trips. Others simply hand over a tablet. Either way, the aim is the same: to make the uncomfortable feeling disappear as quickly as possible.

2 A growing number of psychologists, however, believe that boredom is not an enemy to be defeated. In their view, it is a signal, much like hunger. Hunger tells us that the body needs food; boredom tells us that the mind needs something meaningful to do. If adults always rush to switch off the signal, children may never learn how to respond to it by themselves.

3 An experiment carried out by a team led by the psychologist Dr. Lena Hart suggests that boredom can even be useful. Half of the volunteers were first asked to spend twenty minutes sorting a large pile of dried beans by color, a task chosen because it was extremely dull. The other half went straight to the second stage, in which everyone was asked to think of as many uses as possible for an ordinary paper clip. The volunteers who had sorted beans came up with more ideas, and many of their ideas were more unusual. **(A)** This suggests that when the mind has nothing interesting to hold on to, it begins to wander, and a wandering mind is good at making new connections.

4 Yet many children today rarely have the chance to be bored. Their days are （ ② ） by adults from morning to night, and in the short gaps between activities a screen is almost always within reach. Screens can be useful, of course. The trouble is that a screen （ ③ ） a child to escape boredom instantly, without ever （ ④ ） what he or she might do with the time alone.

5 A primary school teacher, Clara Moreno, decided to try an experiment of her own. Every Friday afternoon, she gave her class forty minutes with no plan, no screens and nothing but a box of everyday materials: string, old newspapers, cardboard and tape. During the first few weeks, the room was full of complaints. （ B ）, something began to change. One group built a model of their neighborhood out of boxes; another wrote and performed a short play. A quiet boy who seldom spoke in class spent several weeks designing a board game, which soon became the most popular activity in the room.

6 Ms. Moreno says that the most important lesson was not about creativity but about patience. “At first, the children expected me to solve their boredom for them,” she explains. “Later they discovered that if they waited a little and tried things out, an idea usually came. Some of the best ideas came after the longest silences.”

7 Of course, not all boredom is helpful. Pupils who are bored in class day after day because the lessons are far too easy or far too difficult may lose interest in learning altogether, and long periods of boredom in adults have been linked to stress and unhealthy habits. The researchers are careful to point out that **(C)** the kind of boredom they have in mind is short and free: a gap in the day that a person is allowed to fill in his or her own way.

8 **(D)** What children need, then, is not a life without boredom but the chance to find out that boredom does not last forever if they do something about it. The next time a child complains that there is nothing to

do, perhaps the best answer is a smile and a simple reply: “I’m sure you’ll think of something.”

〔注〕 *dread*：～をひどく恐れる　*switch off* ～：～を切る　*dried bean*：乾燥した豆　*paper clip*：ゼムクリップ
wander：さまよう　*cardboard*：段ボール　*board game*：ボードゲーム　*altogether*：すっかり

設　問

問1 本文中の空所（　①　）～（　④　）に入れる語を下の語群から選び，必要があれば適切な形に変えて書きなさい。同じ語は1度しか使えない。

allow	depend	discover	fill	organize
reduce				

問2 下線部(A)の This が指す内容を，本文に即して具体的に日本語で説明しなさい。

問3 本文中の空所（　B　）に入る最も適切なものを，(ア)～(エ)の中から1つ選び，その記号を書きなさい。

(ア) For instance　**(イ)** In short　**(ウ)** Over time　**(エ)** Therefore

問4 第6段落のモレノ先生の話の内容に最も合うことわざを，(ア)～(エ)の中から1つ選び，その記号を書きなさい。

(ア)　Strike while the iron is hot.
(イ)　Good things come to those who wait.
(ウ)　Too many cooks spoil the broth.
(エ)　Actions speak louder than words.

問5 下線部(C)が表す内容に最も近いものを，(ア)～(エ)の中から1つ選び，その記号を書きなさい。

(ア) 短い時間で，何をするかを本人が自分で決めてよい退屈　**(イ)** 授業が合わないために学校で毎日続く退屈

(ウ) 大人が前もって計画を立ててくれる短い自由時間　**(エ)** お金をかけずに遊ぶことのできる時間

問6 下線部(D)を和訳しなさい。

問7 次の英文は，本文を読んだ高校生が書いた感想である。空所（　⑤　）～（　⑧　）に入る最も適切な語を，(ア)～(ク)の中からそれぞれ1つ選び，その記号を書きなさい。同じ記号は1度しか使えない。

This passage taught me that boredom works like a （　⑤　） which tells us that our mind needs something to do. In Ms. Moreno’s class, the children （　⑥　） about having no plan at first, but later they created many things. I also learned that boredom is not always good: if it continues for a （　⑦　） time, it can be harmful. From now on, I would like to （　⑧　） my free time in my own way instead of always looking at a screen.

(ア) long　**(イ)** reward　**(ウ)** fill　**(エ)** signal
(オ) complained　**(カ)** short　**(キ)** avoid　**(ク)** laughed

2 長文読解（配点 36）

次の英文を読み，下の設問に答えなさい。

The Medicine That Stays in the Bottle

1 Modern medicine has produced drugs that can control blood pressure, prevent heart attacks and keep diseases such as diabetes in check. Yet many of these drugs never do their job, for a surprisingly simple reason: patients do not take them. Doctors call this problem “non-adherence,” and some experts believe it causes as much harm as many diseases themselves.

2 The scale of the problem is large. Studies in several countries suggest that around half of all patients with long-term conditions do not take their medicine as their doctor intended. Some never collect their prescription from the pharmacy. Others start the treatment but stop after a few weeks, or take it only on days when they remember. The result is that illnesses which could have been controlled become worse, and patients end up in hospital, which is far more expensive for everyone.

3 It is tempting to blame patients for being lazy or careless, but researchers say the real reasons are more complicated. At Riverside Health Clinic, a team led by the pharmacist Dr. Samuel Price interviewed more than three hundred patients who had stopped taking their medicine. Very few said they had simply forgotten. Much more often, they had made a deliberate decision. In other words, most of them had thought about the medicine and chosen not to take it, even if they had not told their doctor.

4 One common reason was that patients felt perfectly well. High blood pressure, for example, usually has no symptoms, so a patient may wonder why he should take a pill every day when nothing seems to be wrong. Another reason was fear of side effects. Some patients had read frightening stories online and decided that the risks of the drug were greater than the risks of the disease. Cost was also important: when patients had to pay a large share of the price themselves, many quietly took fewer pills to make the medicine last longer.

5 Dr. Price’s team also found that many patients had never really understood why the medicine was needed. In a busy clinic, a doctor may have only a few minutes with each patient. **(A)** Patients often leave the room with a prescription in their hand but without a clear idea of what the drug does or what might happen if they stop taking it. Some said they had been too embarrassed to ask questions.

6 Based on these findings, the clinic tried a new approach. Instead of simply handing over a prescription, a pharmacist now meets each new patient for a short conversation. The pharmacist explains in plain language what the medicine is for, asks what worries the patient has, and discusses how the pills could fit into the patient’s daily routine, such as taking them with breakfast. Patients who are worried about cost are told about cheaper options.

7 Simple tools also help. Patients receive a weekly pill box with a separate section for each day, so they can see at a glance whether they have taken today’s dose. Those who agree are sent a short text message if they have not collected their next prescription on time. The pharmacists also call some patients a few weeks after the first visit to ask whether any problems have come up. After a year, the proportion of patients who were still taking their medicine correctly had risen from about half to nearly three quarters.

8 Dr. Price believes the most important change was not the pill boxes or the messages but the conversation itself. “For years we treated patients as people who should follow instructions,” he says.

“Now we treat them as partners who make decisions about their own health. When people understand the reasons and feel that their concerns are taken seriously, most of them choose to take their medicine.” He adds that the best drug in the world is useless if it stays in the bottle.

〔注〕 *diabetes*：糖尿病　　*keep ～ in check*：～を抑える　　*adherence*：（治療の）順守
prescription：処方せん・処方薬　　*pharmacy*：薬局　　*pharmacist*：薬剤師　　*symptom*：症状
dose：（薬の）1回分

設　問

問1 第2段落の内容に合うように，次の英文の下線部に入る語句を英単語3語以上で書きなさい。
When patients do not take their medicine, their illnesses may get worse and they may _____.

問2 第4段落で，高血圧の患者が毎日薬を飲む理由に疑問をもつことがあるのはなぜか。その理由を本文に即して日本語で説明しなさい。

問3 第4段落と第5段落から，患者が薬を飲むのをやめてしまう理由を3つ，それぞれ25字以内の日本語で書きなさい（句読点も1字に数える）。解答欄には(1)～(3)の番号をつけて書くこと。

問4 下線部(A)を和訳しなさい。

3 語句整序（配点 24）

次の英文の【 ① 】～【 ⑥ 】には，下の a～f の [ ] 内の語句を並べ替えてできる英語が1つずつ入る。[ ] 内の語句を正しい順序にし，【 ① 】～【 ⑥ 】に入る英語をそれぞれ解答欄に書きなさい（a～f の記号は書かなくてよい）。ただし，文頭に来る語も小文字で示してある。

Listening to the Body

1 Few objects are as closely connected with doctors as the stethoscope. Hanging around the neck of a doctor, it has become a symbol of the medical profession itself, and many children who play “doctor” at home ask for a toy one. Yet this simple tool is only about two hundred years old, and 【 ① 】.

2 Before the stethoscope, doctors who wanted to hear the sounds inside a patient’s chest had to press an ear directly against the body. This method had obvious problems. It was uncomfortable for both doctor and patient, and the sounds were often too faint to be useful. In the early nineteenth century, a French doctor faced exactly this difficulty with a young patient. He rolled a sheet of paper into a tube, placed one end on her chest and put his ear to the other. To his surprise, 【 ② 】 than he had ever heard it before.

3 He soon replaced the paper with a wooden tube and spent several years studying the sounds made by healthy and diseased lungs and hearts. By carefully comparing what he heard with what was later found in his patients’ bodies, 【 ③ 】 that doctors could use to identify particular illnesses. His work changed medicine, because for the first time doctors could learn about the inside of a living body without opening it.

4 Over the following decades, the stethoscope was improved again and again. The single wooden tube gave way to rubber tubes and two earpieces, 【 ④ 】 with both ears at once. Later models added a flat disc that made it easier to pick up high sounds, and a cup that was better for low ones.

5 Today, some people wonder whether the stethoscope still has a future. Machines that use sound waves can now produce detailed pictures of the heart, and they show far more than any doctor can hear. Some medical schools have even reported that 【 ⑤ 】 as well as students did in the past. Supporters of the old tool reply that it is cheap, needs no electricity and can be carried anywhere.

6 There is another reason why many doctors want to keep it. Placing a stethoscope on a patient’s chest requires the doctor to come close, to touch the patient and to pay full attention for a moment. For many patients, this simple act is reassuring. As one experienced doctor put it, 【 ⑥ 】 is often the first step towards helping them.

〔注〕 *stethoscope*：聴診器　*profession*：（専門的な）職業　*faint*：かすかな　*lung*：肺
give way to ～：～に取って代わられる　*earpiece*：（耳に入れる）イヤーピース　*disc*：円盤
reassuring：安心させる

a. [to / listen / allowed / doctors / which]
b. [the heart / he / more clearly / could hear / beating]
c. [is / how / surprisingly simple / was invented / the story of / it]
d. [he / a / list / of / sounds / built up]
e. [the tool / many / use / cannot / young doctors]
f. [that / listening / patients / you / showing / to / them / are]

解答用紙

予想問題 第2回 英語（医学部（医学科・先進医療科学科）） 1枚目／3枚　受験番号　氏名

〔1〕

問1

①	②	③	④

問2

問3

記号

問4

記号

問5

記号

問6

問7

⑤	⑥	⑦	⑧

得　点

解答用紙

予想問題 第2回 英語（医学部（医学科・先進医療科学科）） 2枚目／3枚　受験番号　氏名

〔2〕

問1

問2

問3

問4

得　点

解答用紙

予想問題 第2回 英語（医学部（医学科・先進医療科学科）） 3枚目／3枚　受験番号　氏名

〔3〕

【①】

【②】

【③】

【④】

【⑤】

【⑥】

得　点

奥　付

書名	国公立2次 予想問題 第2回 英語（医学部（医学科・先進医療科学科）） 問題
想定	大分大学 一般選抜 前期日程（医学部（医学科・先進医療科学科）の個別学力検査「英語」）の出題形式に準拠
構成	〔1〕長文読解（3学部共通）／〔2〕長文読解（医療の話題）／〔3〕語句の並べ替え（本文の【①】〜【⑥】に入れる）／80 分／100 点（40・36・24。大問・小問の配点は編集部の想定）
編集・作成	学習アプリ マナトビ 編集部（2026年11月）

大分大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。
英文・日本文・設問・解答・解説はすべて編集部の書き下ろしです。実際の試験の問題文・解答例の文章は引用していません。

本冊子の無断転載・複製を禁じます。学習アプリ マナトビの利用者が個人の学習に使う範囲でご利用ください。

予想問題 第2回

英　　語

（ 80 分 ・ 100 点 ）

解答・解説

（解答・解説 2〜10 ページ）

大分大学 一般選抜 前期日程 対策

医学部（医学科・先進医療科学科）

はじめに読むこと

1. 各大問の最初に解答一覧と配点（編集部の想定）をまとめた。
2. 日本語・英語で書く問題の解答は一例である。「採点の目安」の要素がそろっていれば，表現が違っても得点としてよい。
3. 長文には全訳と語句をつけた。答え合わせのあと，根拠になる段落をもう一度読み直すこと。
4. 英作文は解答例を 2 つずつ示し，使える言い方と間違えやすい点を書いた。

大分大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。
出題の傾向を研究し，編集部が一から書き下ろした演習用の冊子です。

1 長文読解 ― 解答・解説（配点 40）

本文 614 語

解答一覧

設問	解答	配点
問1	① filling　② organized　③ allows　④ discovering	8
問2	解答例を参照	6
問3	(ウ)	2
問4	(イ)	2
問5	(ア)	6
問6	解答例を参照	8
問7	⑤ (エ)　⑥ (オ)　⑦ (ア)　⑧ (ウ)	8
合計		**40**

問1 語形変化を伴う空所補充（8点）

【解答】① filling　② organized　③ allows　④ discovering

① 前置詞 by のあとなので動名詞 filling。fill A with B「A を B で埋める」。② Their days are 〜 by adults の受け身なので過去分詞 organized「大人によって組み立てられる」。③ 主語 a screen は3人称単数・現在。allow 人 to do「人が〜するのを可能にする」→ allows。④ 前置詞 without のあとなので動名詞 discovering。（各5点）

問2 指示語の内容説明（6点）

【解答例】豆を色ごとに分けるという退屈な作業を先にしたボランティアのほうが，ゼムクリップの使い道をより多く，しかもより風変わりなものまで思いついたこと。

This は直前の文（実験の結果）を指す。「退屈な作業をした人」と「しなかった人」の比較であることを示し，「アイデアの数が多い」「より風変わり」の2点を入れる。実験の手順だけを書いても結果がなければ得点にならない。

採点の目安（6点）

- 退屈な作業（豆を色ごとに分ける作業）を先にした人たちについての結果であることを書いている（2点）
- 使い道（アイデア）をより多く思いついたことを書いている（2点）
- そのアイデアがより風変わりだったことを書いている（2点）

問3 空所補充（つなぎの語句）（2点）

【解答】(ウ)

「最初の数週間は不満でいっぱいだった」→「（　）何かが変わり始めた」。時間がたつにつれての変化なので Over time「時がたつにつれて」。Therefore「したがって」では不満が変化の原因になってしまい，意味が通らない。

問4 ことわざ（2点）

【解答】(イ)

「少し待っていろいろ試せばアイデアが浮かぶ」「いちばん長い沈黙のあとによいアイデアが出た」は忍耐の大切さを述べている。イ「待つ者には良いことが訪れる（待てば海路の日和あり）」。ア「鉄は熱いうちに打て」は逆にすぐ行動せよという意味。

問5　下線部の内容（6点）

【解答】(ア)

コロンのあとの a gap in the day that a person is allowed to fill in his or her own way が言いかえになっている。free は「無料の」ではなく「（何をするかが）自由な」の意味なのでエは誤り。イは前の文で「役に立たない退屈」として挙げられた例。

問6　下線部和訳（8点）

【解答例】だとすれば，子どもに必要なのは退屈のない生活ではなく，何か手を打てば退屈はいつまでも続くわけではないと知る機会である。

What children need が主語（関係代名詞 what「〜もの・こと」）。then は「それならば・だとすれば」で，前の段落までの内容を受ける。not A but B「A ではなく B」。the chance to find out that 〜「〜と知る機会」。does not last forever は部分否定的に「いつまでも続くわけではない」。if they do something about it の it は boredom。

採点の目安（8点）

- What children need を「子どもに必要なもの（こと）」と訳している（2点）
- not A but B の構造を正しく訳している（2点）
- the chance to find out that 〜 を「〜と知る（分かる）機会」と訳している（2点）
- boredom does not last forever if they do something about it を正しく訳している（2点）

問7　内容理解（感想文の空所）（8点）

【解答】⑤ (エ)　⑥ (オ)　⑦ (ア)　⑧ (ウ)

⑤ 第2段落「退屈は空腹とよく似た合図」→ signal。⑥ 第5段落「最初の数週間は不満でいっぱい」→ complained。⑦ 第7段落「長期間の退屈はストレスなどと結びつく」→ long。⑧ 第7段落「自分のやり方で埋めてよいすき間」→ fill。（各5点）

全訳

1 親たちに長い夏休みの間に何がいちばん怖いかと聞いてみると，多くの人が同じ答えを返すだろう。子どもが「退屈だ」と言う瞬間である。その日の1時間1時間を習い事やスポーツや旅行で埋めることで応じる親もいる。ただタブレットを渡すだけの親もいる。いずれにしても，目的は同じだ。その居心地の悪い気持ちをできるだけ早く消してしまうことである。

2 しかし，退屈は打ち負かすべき敵ではないと考える心理学者が増えている。彼らの見方では，退屈は空腹とよく似た合図である。空腹は体が食べ物を必要としていることを教えてくれ，退屈は心が何か意味のあることを必要としていることを教えてくれる。もし大人がいつも急いでその合図を切ってしまえば，子どもはそれに自分で応える方法を決して身につけないかもしれない。

3 心理学者レナ・ハート博士が率いるチームが行った実験は，退屈が役に立つことさえあると示している。ボランティアの半数は，まず大量の乾燥した豆を色ごとに分ける作業を20分間するよう求められた。これはきわめて退屈だという理由で選ばれた作業である。残りの半数はすぐに第2段階に進み，そこでは全員が，ありふれたゼムクリップの使い道をできるだけ多く考えるよう求められた。豆を分けたボランティアのほうがより多くのアイデアを思いつき，そのアイデアの

多くはより風変わりなものだった。このことは，心が何も面白いものをつかんでいないときにはさまよい始め，さまよう心は新しいつながりを作るのが得意だということを示している。

4 しかし今日の多くの子どもには，退屈する機会がめったにない。彼らの1日は朝から晩まで大人によって組み立てられ，活動と活動の間の短いすき間にも，画面がほとんどいつも手の届くところにある。もちろん画面は役に立つこともある。問題は，画面があると，子どもはひとりの時間に何ができるかを一度も見つけることなく，たちまち退屈から逃げられてしまうことである。

5 小学校の教師クララ・モレノは，自分でも実験をしてみることにした。毎週金曜日の午後，彼女はクラスに，計画も画面もなく，ひも，古新聞，段ボール，テープといった身近な材料の入った箱だけがある40分間を与えた。最初の数週間，教室は不満でいっぱいだった。やがて，何かが変わり始めた。あるグループは箱で自分たちの近所の模型を作り，別のグループは短い劇を書いて演じた。授業ではめったに話さないおとなしい男の子は，何週間もかけてボードゲームを考え，それはすぐに教室でいちばん人気のある活動になった。

6 モレノ先生は，いちばん大切な教訓は創造性についてではなく忍耐についてだったと言う。「最初，子どもたちは私が退屈を解決してくれると思っていました」と彼女は説明する。「あとになって，少し待っていろいろ試してみれば，たいていアイデアが浮かぶことに気づいたのです。いちばんよいアイデアのいくつかは，いちばん長い沈黙のあとに出てきました。」

7 もちろん，すべての退屈が役に立つわけではない。授業がやさしすぎたり難しすぎたりするために毎日退屈している生徒は，学ぶことへの興味をすっかり失ってしまうかもしれないし，大人の長期間の退屈はストレスや不健康な習慣と結びつけられてきた。研究者たちは，自分たちが考えている退屈は短くて自由なものだと注意深く指摘している。つまり，その人が自分のやり方で埋めてよい，1日の中のすき間である。

8 だとすれば，子どもに必要なのは退屈のない生活ではなく，何か手を打てば退屈はいつまでも続くわけではないと知る機会である。今度子どもが何もすることがないと不満を言ったら，いちばんよい答えは，笑顔と「きっと何か思いつくよ」という簡単なひと言なのかもしれない。

語句

either way　どちらにしても
defeat　打ち負かす
meaningful　意味のある
carry out ～　～を行う
come up with ～　～を思いつく
hold on to ～　～をつかんで離さない
within reach　手の届くところに
instantly　たちまち
seldom　めったに～ない
try ～ *out*　～を試してみる
point out ～　～を指摘する
have ～ *in mind*　～を念頭に置く

2 長文読解 ― 解答・解説（配点 36）

本文 642 語

解答一覧

設問	解答	配点
問1	have to go into hospital	6
問2	解答例を参照	6
問3	解答例を参照	12
問4	解答例を参照	12
合計		**36**

問1 英文の完成（3語以上）（6点）

【解答例】have to go into hospital ／ end up in hospital ／ need to stay in hospital

第2段落最終文 illnesses which could have been controlled become worse, and patients end up in hospital が根拠。may のあとなので動詞の原形で始める（end up in hospital / have to go into hospital）。

採点の目安（6点）

- 「入院することになる」という内容になっている（4点）
- 助動詞 may に続く形（動詞の原形）で，文法的に正しい（3語以上）（2点）

問2 理由説明（日本語）（6点）

【解答例】高血圧にはふつう症状がないので，患者はどこも悪くないように感じてしまうから。

High blood pressure, for example, usually has no symptoms, so a patient may wonder why … when nothing seems to be wrong. が根拠。「症状がない」と「悪いところがないように思える」の2点を書く。

採点の目安（6点）

- 高血圧にはふつう症状がないことを書いている（4点）
- そのため，どこも悪くないように感じることを書いている（2点）

問3 内容説明（25字以内×3）（12点）

【解答例】(1)体調がよく，飲む必要を感じないから。(2)ネットの情報などで副作用を恐れるから。(3)費用の負担が大きく，量を減らすから。

第4段落：元気だと感じる／副作用への恐れ／費用。第5段落：薬が必要な理由を理解していない（質問できなかった）。この4つのうち3つが書けていればよい。「単に忘れた」は第3段落でごく少数とされているので，主な理由としては誤り。

採点の目安（12点）

- 元気だと感じる・副作用への恐れ・費用・必要性を理解していない のうち1つ目（25字以内）（4点）
- 同じく2つ目（25字以内）（4点）
- 同じく3つ目（25字以内）（4点）

問4 下線部和訳（12点）

【解答例】患者は処方せんを手にしてはいても，その薬が何をするのか，飲むのをやめたら何が起こりうるのかをはっきり分からないまま診察室を出ることが多い。

with a prescription in their hand「処方せんを手にして」と but without a clear idea of 〜「〜がはっきり分からないまま」が対比になっている。idea of のあとに what the drug does と what might happen if 〜 の2つの間接疑問が or で並ぶ。might は「起こるかもしれない」。

採点の目安（12点）

- leave the room with a prescription in their hand を正しく訳している（3点）
- but without a clear idea of 〜 を「〜がはっきり分からないまま」と訳している（4点）
- what the drug does と what might happen if they stop taking it を正しく訳している（5点）

全訳

1 現代医学は，血圧を抑え，心臓発作を防ぎ，糖尿病のような病気を抑えることのできる薬を生み出してきた。しかし，これらの薬の多くは，驚くほど単純な理由で役目を果たさない。患者が飲まないのである。医師はこの問題を「ノンアドヒアランス（服薬不順守）」と呼び，それが多くの病気そのものと同じくらいの害をもたらしていると考える専門家もいる。

2 この問題の規模は大きい。いくつかの国の研究によれば，長期にわたる病気を抱える患者のおよそ半数が，医師が意図したとおりに薬を飲んでいない。処方された薬を薬局に受け取りに行かない人もいる。治療を始めても数週間でやめてしまったり，思い出した日にだけ飲んだりする人もいる。その結果，抑えることができたはずの病気が悪化し，患者は結局入院することになるが，それは誰にとってもはるかに費用がかかる。

3 患者が怠けている，不注意だと責めたくなるが，研究者たちは本当の理由はもっと複雑だと言う。リバーサイド健康診療所では，薬剤師サミュエル・プライス博士が率いるチームが，薬を飲むのをやめた300人以上の患者に聞き取り調査をした。単に忘れていたと答えた人はごくわずかだった。それよりはるかに多かったのは，意図して決めていた場合である。つまり，その大部分は薬について考えたうえで，たとえ医師には伝えていなくても，飲まないことを選んでいたのである。

4 よくある理由の一つは，患者がまったく元気だと感じていることだった。たとえば高血圧にはふつう症状がないので，どこも悪くないように思えるのに，なぜ毎日錠剤を飲まなければならないのかと患者は疑問に思うかもしれない。もう一つの理由は副作用への恐れだった。ネットで怖い話を読み，薬の危険のほうが病気の危険より大きいと判断した患者もいた。費用も重要だった。患者が値段の大部分を自分で払わなければならない場合，多くの人は薬を長もちさせるために，こっそり飲む錠剤の数を減らしていた。

5 プライス博士のチームはまた，多くの患者が，なぜその薬が必要なのかを本当には理解していなかったことも見つけた。忙しい診療所では，医師は患者一人に数分しかかけられないこともある。患者は処方せんを手にしてはいても，その薬が何をするのか，飲むのをやめたら何が起こりうるのかをはっきり分からないまま診察室を出ることが多い。恥ずかしくて質問できなかったと言う人もいた。

6 これらの結果をもとに，診療所は新しいやり方を試した。今では，ただ処方せんを渡すのではなく，薬剤師が新しい患者一人一人と短い話し合いの時間をもつ。薬剤師は，その薬が何のためのものかを分かりやすい言葉で説明し，患者が

どんな心配を抱えているかを尋ね，朝食と一緒に飲むなど，錠剤を患者の毎日の生活にどう組み込めるかを話し合う。費用を心配している患者には，より安い選択肢が伝えられる。

7 簡単な道具も役に立つ。患者には曜日ごとに区切られた1週間分のピルケースが渡されるので，今日の分を飲んだかどうかがひと目で分かる。同意した人には，次の処方薬を期日までに受け取っていない場合に短いメッセージが送られる。薬剤師はまた，最初の面談の数週間後に一部の患者に電話をかけ，何か問題が起きていないかを尋ねる。1年後，薬を正しく飲み続けている患者の割合は，約半数から4分の3近くにまで上がった。

8 プライス博士は，最も重要な変化はピルケースやメッセージではなく，話し合いそのものだったと考えている。「長年，私たちは患者を指示に従うべき人として扱ってきました」と彼は言う。「今では，自分の健康について決定を下すパートナーとして扱っています。理由が分かり，自分の心配が真剣に受け止められていると感じれば，ほとんどの人は薬を飲むことを選ぶのです。」世界で最もよい薬も，瓶の中に入ったままでは役に立たない，と彼は付け加える。

語句

blood pressure　血圧
heart attack　心臓発作
long-term　長期の
end up ～　結局～になる
tempting　（～したい）気にさせる
deliberate　意図的な
side effect　副作用
share　割合・分担
embarrassed　恥ずかしい
plain　分かりやすい
at a glance　ひと目で
proportion　割合
take ～ *seriously*　～を真剣に受け止める

3 語句整序 — 解答・解説（配点 24）

本文 393 語

解答一覧（a〜f は入る記号。解答欄には英文だけを書く）

設問	解答	配点
【①】	c. the story of how it was invented is surprisingly simple	4
【②】	b. he could hear the heart beating more clearly	4
【③】	d. he built up a list of sounds	4
【④】	a. which allowed doctors to listen	4
【⑤】	e. many young doctors cannot use the tool	4
【⑥】	f. showing patients that you are listening to them	4
合計		**24**

- 【①】**c**　主語は the story of how it was invented「それがどのように発明されたかという話」（前置詞 of のあとに間接疑問 how ＋ S ＋ V）。動詞 is ＋ 補語 surprisingly simple。
- 【②】**b**　後ろの than he had ever heard it before と比較の形がそろう（it = the heart）。hear O doing「O が〜しているのを聞く」。
- 【③】**d**　文頭の By carefully comparing … は分詞的な前置き（〜することによって）で，主節の主語は he。build up「（少しずつ）作り上げる」。後ろの that doctors could use … は a list of sounds を修飾する関係代名詞。
- 【④】**a**　コンマのあとの非制限用法の which が「ゴム管と2つのイヤーピース」を受ける。allow 人 to do「人が〜できるようにする」。続きの with both ears at once「両耳で同時に」とつながる。
- 【⑤】**e**　that 節の主語 many young doctors ＋ cannot use ＋ 目的語 the tool。後ろの as well as students did in the past「昔の学生ほど上手に」と比べている。did は used the tool の代わり。
- 【⑥】**f**　動名詞 showing が主語で，後ろの is often the first step の主語になる。show 人 that 〜「人に〜ということを示す」。listen to them「彼らの話を聞く」の現在進行形。

完成した本文（太字が入れた部分）

1 Few objects are as closely connected with doctors as the stethoscope. Hanging around the neck of a doctor, it has become a symbol of the medical profession itself, and many children who play “doctor” at home ask for a toy one. Yet this simple tool is only about two hundred years old, and **the story of how it was invented is surprisingly simple**.

2 Before the stethoscope, doctors who wanted to hear the sounds inside a patient’s chest had to press an ear directly against the body. This method had obvious problems. It was uncomfortable for both doctor and patient, and the sounds were often too faint to be useful. In the early nineteenth century, a French doctor faced exactly this difficulty with a young patient. He rolled a sheet of paper into a tube, placed one end on her chest and put his ear to the other. To his surprise, **he could hear the heart beating more clearly** than he had ever heard it before.

3 He soon replaced the paper with a wooden tube and spent several years studying the sounds made by healthy and diseased lungs and hearts. By carefully comparing what he heard with what was later found in his patients’ bodies, **he built up a list of sounds** that doctors could use to identify particular illnesses. His work changed medicine, because for the first time doctors could learn about the inside of a living body without opening it.

4 Over the following decades, the stethoscope was improved again and again. The single wooden tube gave way to rubber tubes and two earpieces, **which allowed doctors to listen** with both ears at once. Later models added a flat disc that made it easier to pick up high sounds, and a cup that was better for low ones.

5 Today, some people wonder whether the stethoscope still has a future. Machines that use sound waves can now produce detailed pictures of the heart, and they show far more than any doctor can hear. Some medical schools have even reported that **many young doctors cannot use the tool** as well as students did in the past. Supporters of the old tool reply that it is cheap, needs no electricity and can be carried anywhere.

6 There is another reason why many doctors want to keep it. Placing a stethoscope on a patient's chest requires the doctor to come close, to touch the patient and to pay full attention for a moment. For many patients, this simple act is reassuring. As one experienced doctor put it, **showing patients that you are listening to them** is often the first step towards helping them.

全訳

1 聴診器ほど医師と深く結びついている物はほとんどない。医師の首にかけられたそれは，医療という職業そのものの象徴になっており，家で「お医者さんごっこ」をする子どもの多くはおもちゃの聴診器を欲しがる。しかし，この単純な道具はほんの200年ほどの歴史しかなく，それがどのように発明されたかという話は驚くほど単純である。

2 聴診器ができる前は，患者の胸の中の音を聞きたい医師は，耳を直接体に押し当てなければならなかった。この方法には明らかな問題があった。医師にとっても患者にとっても気まずく，音はかすかすぎて役に立たないことが多かった。19世紀の初め，あるフランス人医師が，若い患者を前にしてまさにこの困難に直面した。彼は1枚の紙を丸めて筒にし，一方の端を彼女の胸に当て，もう一方の端に耳をつけた。驚いたことに，心臓が鼓動しているのが，それまで聞いたどんなときよりもはっきりと聞こえたのである。

3 彼はすぐに紙を木の筒に替え，健康な肺や心臓と病気の肺や心臓が立てる音を何年もかけて研究した。聞こえた音と，あとで患者の体の中に見つかったものを注意深く比べることによって，彼は，医師が特定の病気を見分けるのに使える音の一覧を作り上げた。彼の研究は医学を変えた。医師が初めて，生きている体を開かずにその内部について知ることができるようになったからである。

4 その後の数十年間で，聴診器は何度も改良された。1本の木の筒はゴム管と2つのイヤーピースに取って代わられ，医師は両耳で同時に聞けるようになった。のちの型には，高い音を拾いやすくする平らな円盤と，低い音に向いたカップが加えられた。

5 今日，聴診器にまだ未来があるのかと疑問に思う人もいる。音波を使う機械は今では心臓の詳しい画像を作り出すことができ，それはどんな医師が聞き取れるよりもはるかに多くのことを示す。多くの若い医師は昔の学生ほど上手にその道具を使えないと報告している医学部さえある。古い道具を支持する人々は，聴診器は安く，電気がいらず，どこへでも持ち運べると反論する。

6 多くの医師がそれを残したいと思う理由はもう一つある。患者の胸に聴診器を当てるには，医師が近づき，患者に触れ，少しの間すべての注意を向けることが必要になる。多くの患者にとって，この単純な行為は安心できるものである。ある経験豊かな医師が言ったように，自分が話を聞いていることを患者に示すことが，しばしば患者を助ける第一歩なのである。

語句

be connected with 〜　〜と結びついている
symbol　象徴
press A against B　AをBに押し当てる
obvious　明らかな

to one's surprise　驚いたことに
identify　見分ける
decade　10年間

pick up 〜　（音など）を拾う
as ... put it　...が言ったように

奥　付

書名	国公立2次 予想問題 第2回 英語（医学部（医学科・先進医療科学科）） 解答・解説
想定	大分大学 一般選抜 前期日程（医学部（医学科・先進医療科学科）の個別学力検査「英語」）の出題形式に準拠
構成	〔1〕長文読解（3学部共通）／〔2〕長文読解（医療の話題）／〔3〕語句の並べ替え（本文の【①】〜【⑥】に入れる）／80 分／100 点（40・36・24。大問・小問の配点は編集部の想定）
編集・作成	学習アプリ マナトビ 編集部（2026年11月）

大分大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。
英文・日本文・設問・解答・解説はすべて編集部の書き下ろしです。実際の試験の問題文・解答例の文章は引用していません。

本冊子の無断転載・複製を禁じます。学習アプリ マナトビの利用者が個人の学習に使う範囲でご利用ください。